

**Universidad Nacional Mayor de San Marcos Universidad
del Perú. Decana de América**
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Medicina Humana



**Nivel y Factores asociados con la agresividad de los usuarios
externos que acuden al Centro de Salud San Miguel “Manuel
Bertorini Jordan”2025**

PROYECTO DE TESIS

Para optar el Título Profesional de Médico Cirujano

AUTOR

Miriam VALENCIA RIVERA

ASESOR

Dr. Miguel VERA FLORES

Lima, Perú

Año 2025

ÍNDICE

Contenido

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	3
1.1 Planteamiento del problema	6
1.2 Formulación del problema de investigación	6
1.3 Formulación de objetivos	6
1.3.1 <i>Objetivo general</i>	6
1.3.2 <i>Objetivos específicos</i>	6
1.4 Justificación de la investigación	7
1.5 Limitaciones del estudio	8
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	8
2.1 Marco teórico	8
2.1.1 <i>Antecedentes de la investigación</i>	8
2.1.2 <i>Bases teóricas</i>	15
2.1.3 <i>Definición de términos</i>	19
2.2 Formulación de la hipótesis	20
2.3 Diseño metodológico	20
2.3.1 <i>Tipo de investigación</i>	22
2.3.2 <i>Población</i>	22
2.3.3 <i>Muestra</i>	23
2.3.4 <i>Muestreo</i>	24
2.3.5 <i>Operacionalización de variables</i>	25
2.3.6 <i>Técnica e instrumento de recolección de datos</i>	29
2.3.7 <i>Procedimiento para la recolección de datos</i>	32
2.3.8 <i>Análisis estadístico de los datos</i>	33
2.3.9 <i>Consideraciones éticas</i>	33
CAPÍTULO III:	34
3.1 Cronograma del trabajo	34
3.2 Presupuesto	35
3.3 Recursos disponibles	36
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	38
ANEXOS	46
ANEXO 1: Matriz de consistencia	46
ANEXO 2 : Instrumento de recolección de datos	47
ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ESTUDIO	50
ANEXO 4: Validación por juicio de expertos	51
ANEXO 5: Confiabilidad del Instrumento- Alfa de Cronbach	56
ANEXO 6: Aprobación por el comité de ética de la UNMSM	58

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1 Planteamiento del problema

El estudio de la agresividad en la atención de salud es crucial debido a su impacto en la salud mental y física de los profesionales de la salud. A nivel global, una revisión sistemática de 253 investigaciones reveló que el 61.9% de los trabajadores de salud había experimentado algún tipo de violencia laboral. De este grupo, la violencia verbal fue la más común, afectando a un 57.6% de los encuestados(1). Este fenómeno es especialmente prevalente en entornos de alta tensión, como los departamentos de emergencias y psiquiatría, donde la presión laboral es intensa y las interacciones pueden volverse conflictivas (1).

Además, la hostilidad y la agresión pueden afectar negativamente la salud mental de los profesionales y la calidad de atención que ofrecen, lo que subraya la necesidad de implementar estrategias de prevención y formación adecuadas(1). Así, estudiar la agresividad en este contexto no solo protege a los trabajadores, sino que también asegura una mejor atención para los usuarios.El Instituto Nacional de Salud y Excelencia en la Atención (NICE) en Inglaterra señala que tanto los departamentos de emergencia como las unidades psiquiátricas son particularmente propensos a experimentar episodios de violencia en comparación con otros servicios médicos. Además, se estima que la agresión dirigida al personal de salud no solo contribuye a una mayor tasa de ausencia laboral sino también a una pérdida significativa en la productividad general.(2)

Una investigación realizada en Italia con enfermeros reveló la alarmante prevalencia de agresiones en el entorno de emergencias, donde el 76% de los enfermeros fueron víctimas de agresiones verbales, el 15.5% experimentó tanto violencia física como verbal, y el 8.5% afirmó no haber enfrentado situaciones similares. Factores como la experiencia laboral y una mayor edad emergieron como elementos protectores que contribuyeron a evitar estos incidentes.(3)

De manera similar, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la violencia en el trabajo como un problema de salud pública que requiere

atención urgente, especialmente en entornos de atención médica donde hasta el 62% de los trabajadores de la salud han sufrido violencia en el lugar de trabajo. Los tipos de violencia más comunes incluyen el abuso verbal (58%), las amenazas (33%) y el acoso sexual (12%) (4).

En el contexto regional, en América Latina, la violencia hacia los trabajadores de la salud ha experimentado un alarmante incremento. Un estudio realizado en servicios prehospitalarios de Chile destacó que los profesionales de la salud enfrentan frecuentemente episodios de abuso verbal y acoso laboral. El abuso verbal fue la forma más prevalente de violencia, afectando a un gran porcentaje de los encuestados. Los resultados indican que los principales perpetradores de esta violencia son los pacientes y sus familiares, lo que genera un ambiente hostil que impacta negativamente tanto en la calidad de la atención como en el bienestar de los trabajadores de salud (5). De manera similar, en Brasil, un estudio realizado en Sao Paulo en el 2015 evaluó a 3141 trabajadores de la salud. Los resultados mostraron que el 36.3% presentaron síntomas depresivos intermedios y el 16% mostraron probable depresión mayor. La exposición a la violencia incluyó insultos (44.9%), amenazas (24.8%), agresiones físicas (2.3%) y presenciar violencia (29.5%). Estas experiencias se asociaron con un aumento significativo de los síntomas depresivos, lo que destaca la necesidad de implementar políticas efectivas que aborden la violencia en el trabajo y apoyen la salud mental de los profesionales (6).

A nivel nacional, la agresividad en la atención de salud en Perú también representa un desafío significativo. Según un estudio realizado en Arequipa en 2016, el 84% de los médicos encuestados informaron haber experimentado algún tipo de violencia durante su carrera, siendo la violencia verbal la más común, seguida de la violencia física y el acoso sexual (7). Este hallazgo resalta la magnitud del problema y la necesidad de abordar la violencia en el ámbito sanitario. Además, un estudio realizado en Lima Metropolitana en 2014 reveló que el 31.5% de los médicos experimentaron amenazas de violencia en el trabajo. Los familiares de los pacientes fueron identificados como los principales agresores, constituyendo el 75.3% de los casos de violencia. Este estudio también mostró que el 19.9% de los médicos había sido víctima de violencia en el último año y un 7.6% en el

último mes. Las situaciones de mayor riesgo se presentaron en servicios de emergencia y atención directa al paciente.(8).

La agresividad es un rasgo natural presente en todos los seres humanos, que se manifiesta en diferentes niveles según el contexto. Esta comprensión permite analizar el comportamiento agresivo como una respuesta inherente y natural del ser humano, que puede surgir en determinadas circunstancias como en el primer nivel de atención en salud. Un ejemplo es el centro de salud San Miguel "Manuel Bertorini Jordán" el cual brinda servicios de atención a usuarios que acuden a consulta externa.(9-12)

A pesar de la relevancia del tema y de la existencia de estudios en usuarios psiquiátricos o en servicios de emergencia, existe una brecha significativa en la investigación respecto al nivel de agresividad en usuarios que buscan atención en la consulta externa en el Primer Nivel de Atención. Este ámbito sigue siendo un área insuficientemente explorada, a pesar de que las agresiones, especialmente el abuso verbal, son comunes en estos entornos. Investigaciones recientes señalan que la atención primaria enfrenta importantes desafíos en la gestión de la violencia hacia los profesionales, pero que el foco de estudio ha sido limitado a otros entornos de mayor complejidad. Comprender la magnitud y la naturaleza de la agresividad en este contexto es esencial para mejorar las estrategias de atención, implementar intervenciones preventivas y promover la salud mental de la población atendida(13,14)

En este contexto, se plantea la necesidad de realizar un estudio que analice de manera sistemática el nivel de agresividad en usuarios externos que acuden a consulta externa del CS "San Miguel Manuel Bertorini Jordan", con el propósito de proporcionar información valiosa para fortalecer la atención integral de la salud mental en este entorno.

1.2 Formulación del problema de investigación

¿Cuál es el nivel de agresividad y sus factores asociados en los usuarios externos que acuden al CS San Miguel “Manuel Bertorini Jordan “2025

1.3 Formulación de objetivos

1.3.1 Objetivo general

- Determinar el nivel de agresividad y sus factores asociados en los usuarios externos que acuden al CS San Miguel “Manuel Bertorini Jordan “ 2025

1.3.2 Objetivos específicos

- Determinar el nivel de agresividad según la dimensión agresión física de los usuarios externos que acuden al CS San Miguel “Manuel Bertorini Jordan” en el 2025.
- Determinar el nivel de agresividad según la dimensión agresión verbal de los usuarios externos que acuden al CS San Miguel “Manuel Bertorini Jordan” en el 2025.
- Determinar el nivel de agresividad según la dimensión ira de los usuarios externos que acuden al CS San Miguel “Manuel Bertorini Jordan” en el 2025.
- Determinar el nivel de agresividad según la dimensión hostilidad de los usuarios externos que acuden al CS San Miguel “Manuel Bertorini Jordan” en el 2025.
- Identificar los factores asociados con el nivel de agresividad y sus dimensiones de los usuarios externos que acuden al CS San Miguel “Manuel Bertorini Jordan” en el 2025.

1.4 Justificación de la investigación

La conducta agresiva de los usuarios en contextos médicos es un asunto que merece ser abordado detalladamente, dado el potencial impacto que podría tener al interferir en la dinámica de la relación médico-usuario. Esta relación implica un componente emocional que abarca el miedo, la incertidumbre y sufrimiento, por ello, es necesario estudiar el nivel de agresividad en los usuarios para preservar la calidad de la atención, garantizar la seguridad del personal de atención médica y mejorar la experiencia global del usuario durante la atención recibida.

La necesidad de esta investigación se basa en la evidencia de comportamientos agresivos por parte de los usuarios de salud hacia los trabajadores de la salud. A pesar de que existen estudios sobre la agresividad en el ámbito hospitalario estos se enfocan más en causas de origen psiquiátricas, en poblaciones de usuarios con trastornos psiquiátricos, o en el servicio de emergencia sin embargo no se ha visto estudios que evalúen el nivel de agresividad en usuarios externos que acudan a un centro de primer nivel de atención.

La relevancia de este estudio radica en la posibilidad de obtener un conocimiento más específico del nivel de agresividad en los usuarios externos y los factores asociados, lo cual permitirá implementar estrategias y medidas preventivas. Estas acciones no solo contribuirán a mejorar la seguridad del personal asistencial, sino que también fomentarán un entorno de atención más saludable y una experiencia agradable para los usuarios.

Llevar a cabo esta investigación permitirá aportar al conocimiento sobre el manejo de la agresividad en el primer nivel de atención. Además, facilitará la formulación de futuras políticas internas, la elaboración de protocolos de atención a los usuarios y la implementación de programas de capacitación.

En síntesis, esta investigación permitirá abordar una problemática localizada, proporcionará datos específicos que contribuirán al avance en la

comprensión y manejo de la agresividad en usuarios externos que acuden al primer nivel de atención.

1.5 Limitaciones del estudio

Si bien existen estudios sobre agresividad, existen pocas investigaciones relacionadas al nivel de agresividad en los usuarios que acuden a un centro de salud ,por lo que hay limitados antecedentes.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Marco teórico

2.1.1 Antecedentes de la investigación

A nivel internacional, se tienen los siguientes estudios:

Hidir Sari, İsmail Yıldız y colaboradores llevaron a cabo una investigación cuyo objetivo fue evaluar la frecuencia de la violencia en el lugar de trabajo (WPV) dirigida a los profesionales de la salud y los factores que influyen en estos eventos. El estudio se realizó en 2023 en un hospital universitario de medicina en Italia y tuvo una muestra de 135 profesionales de la salud, cuya edad media fue de 33.32 ± 7.5 años (mínimo 23, máximo 60). Se utilizó un diseño observacional, descriptivo y retrospectivo, y el instrumento que se usó fue un análisis de registros de incidentes de violencia. Se analizaron las características sociodemográficas (edad, género y ocupación), los responsables de los actos violentos, los tipos de violencia, los lugares y los momentos en los que ocurrieron, así como los factores motivadores y la información correspondiente al proceso legal. La violencia en el lugar de trabajo afectó al 1.2% de los 10,821 trabajadores de la salud, siendo en su mayoría verbal (71.9%). Los médicos fueron el grupo más afectado (62.3%), y las consultas externas (34.8%) fueron el escenario principal. Los motivos

incluyeron incumplimiento de procedimientos (triaje), problemas de comunicación (manejo estresante del usuario en la sala de emergencias) e insatisfacción (largas colas de servicios, apatía de los trabajadores sanitarios, impaciencia del usuario e inquietud). El presente estudio concluyó que la frecuencia de violencia en el lugar de trabajo (WPV) fue menor que la reportada en la literatura existente. Los trabajadores de clínicas ambulatorias y servicios de emergencia fueron los más afectados. Se atribuyeron los eventos de WPV a diversos factores prevenibles, como expectativas no claras de los usuarios, desafíos en el cumplimiento de las normas hospitalarias, manejo complicado de los usuarios, problemas de comunicación y carga laboral excesiva.(15)

Yuan Yang et al. llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo fue analizar el patrón de violencia en el lugar de trabajo (WPV) y su relación con la calidad de vida de los médicos de primera línea durante la crisis de la pandemia de COVID-19. El estudio se realizó en 2021 en China y tuvo una muestra de 15,531 participantes, cuya edad media fue de 33.42 años. Se utilizó un diseño de corte transversal entre el 15 y el 20 de marzo de 2020. Como instrumento, se utilizó la Escala de Violencia en el Lugar de Trabajo para medir la experiencia de los médicos con la violencia, así como el Cuestionario de Trastorno de Ansiedad General y el Cuestionario de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud para evaluar síntomas de ansiedad, depresión e insomnio, y la calidad de vida, respectivamente. De los participantes, 2,878 médicos informaron haber experimentado violencia en el lugar de trabajo durante el brote de la pandemia de COVID-19; de estos, 2,507 (16.1%) fueron sometidos a violencia verbal y 1,066 (6.9%) sufrieron violencia física. Se encontró que la violencia en el lugar de trabajo se asoció significativamente con el sexo masculino, la edad avanzada, la experiencia laboral más larga, el nivel de educación superior, la especialidad médica, la experiencia con la epidemia de SARS de 2003, trabajar en hospitales terciarios, en departamentos de hospitalización, cuidar de usuarios infectados y haber infectado a familiares, amigos o colegas, así como el tabaquismo. La conclusión de este trabajo fue que durante la

pandemia de COVID-19, los médicos de primera línea experimentaron una vulnerabilidad significativa a la violencia en el entorno laboral. Debido al impacto negativo de esta violencia en la calidad de atención y la calidad de vida de los médicos, señalaron que es esencial que las autoridades de salud y los responsables de políticas implementen medidas efectivas para reducir la violencia dirigida a los médicos en el lugar de trabajo.(16)

Naveed Haider, Muhammad Sajid y colaboradores realizaron un estudio cuyo objetivo fue analizar los aspectos demográficos y los factores profesionales relacionados con la violencia laboral, así como calcular su incidencia en el año 2021 en el Hospital Universitario DHQ, Dera Ghazi Khan en Pakistan. La investigación contó con la participación de 83 trabajadores de salud, con una edad media de 33 ± 7 años, entre los que se incluían funcionarios médicos, médicos residentes y enfermeras. El diseño fue de tipo descriptivo y se utilizó un cuestionario para recabar los datos, seleccionando a los participantes de manera aleatoria mediante una técnica de asignación proporcional. Los resultados indicaron que más del 96% de los profesionales de la salud experimentaron abusos y agresiones por parte de los pacientes o sus familiares. Además, la totalidad de los encuestados señaló que la falta de educación de los usuarios fue la principal causa del aumento de la agresividad. Entre el 42% y el 54% identificaron el largo tiempo de espera y factores culturales como causas adicionales de la violencia, mientras que entre el 43% y el 66% mencionaron la escasez de personal y el hacinamiento como factores desencadenantes. El 54% también destacó la prolongada espera como un motivo clave detrás de la violencia, y un 84% mencionó la ausencia de medidas eficaces para enfrentar situaciones violentas en el entorno laboral. Los investigadores concluyeron que los profesionales de la salud merecen entornos laborales seguros y deben recibir formación adecuada para manejar situaciones de agresión.(17)

Lisa Pompeii, Elisa Benavides y su equipo realizaron una revisión sistemática con el propósito de abordar la prevalencia, factores de riesgo,

estrategias preventivas, procedimientos de denuncia y consecuencias de la violencia en el lugar de trabajo (WPV) dirigida por usuarios o familiares hacia el personal de salud en el año 2020 en clínicas médicas ambulatorias de Turquía, Australia, Arabia Saudita, Inglaterra, Irlanda, Serbia y España.

Se incluyeron 18 artículos, de los cuales 13 eran estudios cuantitativos y 5 cualitativos. Se utilizó un diseño de revisión sistemática siguiendo las pautas PRISMA. Se analizaron artículos que examinaron la violencia perpetrada por pacientes y familiares contra los trabajadores de la salud en clínicas médicas ambulatorias, utilizando encuestas y análisis de registros. Los estudios incluidos se enfocaron en la frecuencia de WPV tipo II, principalmente abuso verbal, con amenazas de agresión también reportadas. Se observó que las clínicas en zonas rurales tenían una mayor prevalencia de WPV en comparación con las ubicadas en zonas urbanas. Factores de riesgo, como el turno nocturno, se asociaron con una mayor probabilidad de WPV. La mayoría de las agresiones fueron perpetradas por usuarios en lugar de familiares o acompañantes. En cuanto a los factores que influyen en la atención al usuario, se abordaron malentendidos, insatisfacción con las necesidades de servicios y obstáculos en la comunicación. Los elementos clínicos y de seguridad incluyen congestión en la clínica, largos tiempos de espera y falta de medidas de protección. En grupos focales con médicos, se exploró la percepción de la violencia, atribuyéndole causas como enfermedades psiquiátricas, uso de drogas, motivaciones sexuales, pobreza y dislocación social. Se destacó la escasez de publicaciones sobre WPV en clínicas médicas ambulatorias en comparación con hospitales. La conclusión de este trabajo fue que se resalta la violencia en el entorno laboral médico como un importante problema de salud pública y subraya la necesidad de prevención. Además, destaca la importancia de prestar mayor atención a la seguridad y bienestar de los trabajadores en clínicas médicas ambulatorias que ofrecen servicios esenciales de atención primaria en las comunidades (18)

Tao Sun et al. llevaron a cabo una investigación con el propósito de determinar la tasa de incidencia de violencia en el lugar de trabajo (WPV)

contra los médicos. Asimismo, se propusieron analizar la asociación entre la exposición a WPV, el estrés psicológico, la calidad del sueño y la percepción subjetiva de salud en médicos chinos. Además, buscaron verificar el papel mediador parcial del estrés psicológico. El estudio se realizó en 2017 en China, donde se invitó a 3,016 participantes, de los cuales 2,617 completaron la encuesta, alcanzando una tasa de respuesta efectiva del 86.8%. Se utilizó un diseño de tipo transversal y como instrumento de recolección de datos se aplicó una encuesta en línea con una escala Likert de 6 puntos. Los resultados priorizados indicaron que el 76.2% de los encuestados reportaron haber experimentado violencia verbal en los últimos 12 meses. Además, el 58.3% mencionó enfrentar dificultades generadas por otros, el 40.8% reportó difamación de su reputación, el 40.2% sufrió comportamiento de hostigamiento (mobbing), el 27.6% fue víctima de intimidación, el 24.1% experimentó violencia física, el 7.8% mencionó haber sufrido acoso sexual y el 83.4% de los encuestados reportaron haber experimentado más de un tipo de violencia en el lugar de trabajo (WPV). También observaron una asociación significativa entre la exposición a WPV, el estrés psicológico, la calidad del sueño y la salud subjetiva. Además, identificaron que el estrés psicológico actúa como un mediador en la relación entre la exposición a la violencia y los efectos perjudiciales para la salud. La conclusión de este trabajo fue que los médicos chinos experimentaron una alta vulnerabilidad a la violencia en el entorno laboral, lo que afecta negativamente su calidad de atención y calidad de vida. (19)

A nivel de Latinoamérica, se tienen los siguientes estudios:

Ezequiel D. Bravo et al. describieron las situaciones de violencia experimentadas por el personal de enfermería a manos de los usuarios en una entidad de salud pública durante 2021. El proyecto se llevó a cabo en el Hospital Escuela José F. de San Martín, Corrientes, Argentina. Participaron 115 trabajadores de enfermería, de los cuales el 69.57% eran mujeres, con una edad promedio de 35.5 años (rango: 22-56 años). El estudio adoptó un

enfoque observacional, descriptivo y transversal, empleando Google Forms como herramienta para recopilar datos a través de un cuestionario, asegurando el consentimiento informado y la garantía de anonimato. Los resultados revelaron que el 89.56% de los encuestados había experimentado algún tipo de violencia por parte de los usuarios. La violencia sufrida por el personal de enfermería se evaluó en tres categorías: maltrato verbal, maltrato físico y acoso sexual. El 72.17% informó haber sufrido maltrato físico, el 86.09% maltrato verbal, y el 24.35% refirió haber sido víctima de acoso sexual. La conclusión de este trabajo fue que se resalta la presencia de violencia por parte de los usuarios, con diferentes tipos de violencia que afectan a diversas frecuencias, siendo las mujeres las más perjudicadas. La violencia verbal fue la más común, seguida del maltrato físico y el acoso sexual. (20)

A nivel nacional :

Tuya-Figueroa, Mezones-Holguín y colaboradores realizaron una investigación cuyo objetivo principal fue estimar la frecuencia y los factores asociados de la violencia laboral externa en forma de amenaza (VLETA) dirigida a médicos de los servicios de salud hospitalarios. El estudio se llevó a cabo en 2016 en Lima Metropolitana, Perú. Se invitó a participar a un total de 558 médicos, de los cuales 18.8% rechazaron participar, resultando en la inclusión de 406 participantes. La población del estudio incluyó médicos de hospitales del MINSA, EsSalud y una clínica en Lima. El diseño de la investigación fue transversal y analítico, utilizando un cuestionario como herramienta de recolección de datos. Los resultados mostraron que el 59.6% de los participantes reportaron haber presenciado algún tipo de VLETA dirigida a sus colegas. Además, un 31.5% afirmó haber experimentado personalmente VLETA, con un 19.9% que la vivió en los últimos doce meses y un 7.6% en el último mes. Las agresiones ocurrieron con mayor frecuencia en el turno matutino, siendo la sala de emergencias el lugar más común. Los familiares de los usuarios fueron identificados como los principales

agresores, representando el 75.3% de las amenazas. Al analizar los factores asociados, se observó que trabajar en instituciones del MINSA (55.6%) o EsSalud (43.2%), en servicios de emergencia (80.3%) o quirófanos (44.4%), poseer una especialidad quirúrgica (55.6%), ser residente (44.4%), haber completado la formación de pregrado en provincias (42%), y ser de género masculino (76.5%) se asociaron con una frecuencia significativamente mayor de VLETA en los últimos doce meses. La conclusión de este trabajo fue que estos resultados proporcionan un fundamento para la realización de investigaciones futuras que incluyan la medición de variables tanto del agresor como del médico.(8)

Agueda Muñoz del Carpio-Toia et al. llevaron a cabo un estudio cuyo objetivo fue determinar la frecuencia de la violencia contra médicos, así como sus características y la percepción de factores desencadenantes. El estudio se realizó en 2016 en Arequipa, Perú. Se invitó a participar a un total de 200 médicos a través de un muestreo no probabilístico. La metodología del estudio fue observacional, descriptivo y transversal, utilizando el cuestionario de la Organización Internacional del Trabajo como herramienta de recolección de datos. Los resultados revelaron que el 84% de los médicos refirieron haber experimentado violencia en algún momento de su carrera profesional. La violencia verbal (amenazas) fue la más común, seguida de la violencia física y, en menor medida, el acoso sexual. En el 72.2% de las situaciones de violencia, el principal agresor fue un familiar o acompañante del usuario, siendo la emergencia el lugar donde más frecuentemente ocurrió la violencia. Los médicos encuestados identificaron como factores contribuyentes a la violencia en el lugar de trabajo las demandas que superan las capacidades del médico, los tiempos de espera en la atención y la falta de comprensión debido a la carga laboral. Las especialidades más afectadas fueron Emergencia crítica y Psiquiatría. La conclusión de este trabajo es que se destaca la alta frecuencia de la violencia contra los médicos en Arequipa, y se señala que los factores desencadenantes de la violencia no dependen en su mayoría del actuar del médico, sino de las condiciones laborales.(21)

2.1.2 Bases teóricas

2.1.2.1 Agresividad

La agresividad es comúnmente vista como una reacción adaptativa que forma parte de las estrategias de afrontamiento que los seres humanos emplean ante amenazas externas(22)

El concepto de agresividad se usa indistintamente con agitación y violencia , la agitación es un estado de actividad psicomotora excesiva, caracterizado por un aumento de tensión e irritabilidad , lo que resulta en un comportamiento improductivo y repetitivo.

El desarrollo de la agresividad es un fenómeno multifactorial que se encuentra vinculado con diversos aspectos como el entorno, el sistema de atención de salud mental, las normativas, la actitud hacia los usuarios, factores culturales, así como elementos relacionados con el usuario, tales como demografía, estado cognitivo, emocional , malevolencia y patología. Además, influyen factores asociados al médico, como el grado de comunicación, habilidades para reducir la tensión y el nivel de estrés de los médicos.(23)

2.1.2.2 Acto violento

Las conductas violentas suelen tener un impacto negativo en las personas a las que va dirigido contribuyendo al deterioro de la calidad de las relaciones y fomentando la aparición de incidentes adversos.(24)La violencia forma parte de la vida de los pabellones psiquiátricos y tiene efectos dañinos para el personal de salud, los usuarios y a la misma institución.(25)Según la OMS cuando nos referimos a actos de violencia psicológica implica desde amenazas, insultos y agresiones verbales mientras que los actos

de violencia física implica uso de la fuerza o amenaza de fuerza contra una persona. (26)

Un accidente de trabajo es un evento inesperado y no planificado que van a incluir actos de violencia no consentidos que van a terminar en lesiones personales , es por ello que los actos de violencia se clasifican como accidentes de trabajo.(15)

2.1.2.3 Teoría de la agresividad como rasgo universal

La agresividad ha sido conceptualizada como un rasgo natural en todos los seres humanos, presente desde una perspectiva evolutiva que ha facilitado la supervivencia a lo largo de la historia. Desde este enfoque, la agresividad permitió a los individuos defenderse de amenazas, proteger recursos y establecer jerarquías dentro de grupos sociales. Este rasgo no se manifiesta de manera dicotómica, sino que existe en un continuo, donde cada persona exhibe diferentes niveles de agresividad dependiendo del contexto. Así, la agresividad se presenta como un comportamiento adaptativo que varía en su intensidad y expresión, pero está presente en todos los individuos (9,10)

Estudios recientes han reafirmado que incluso las personas con altos niveles de autocontrol pueden exhibir comportamientos agresivos en situaciones de estrés o presión. Este hallazgo sugiere que la agresividad no es exclusiva de aquellos con dificultades para gestionar sus emociones, sino que está latente en todos, activándose bajo ciertas condiciones. Esta conclusión subraya la universalidad de la agresividad como rasgo inherente(11)

El Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry evalúa este rasgo en diversas dimensiones (agresión física, verbal, ira y hostilidad), partiendo del supuesto de que todas las personas poseen algún nivel de agresividad. Esto está alineado con la evidencia teórica

que sostiene que la agresividad es una característica presente en todos los individuos, aunque varíe en su forma de expresión y los factores que la desencadenan(27)

2.1.2.4 Dimensiones de la Agresividad

Agresión física

La agresión física se define como cualquier acción que implica el uso de la fuerza con el propósito de causar daño físico a otra persona. Este tipo de agresión es uno de los indicadores más directos de conducta violenta y está relacionada con factores psicológicos y situacionales(1,27).La agresión física puede manifestarse en diversas formas, desde empujones hasta lesiones graves (28,29). Además, se ha observado que este tipo de agresión es más prevalente en entornos de alta tensión, como en el ámbito de la salud (1).

Agresión verbal

La agresión verbal se define como el uso de palabras para insultar, amenazar o herir emocionalmente a otra persona. Este tipo de agresión es común en las interacciones sociales y, aunque no causa daño físico, puede tener efectos psicológicos profundos en las víctimas (29). Buss y Perry identifican la agresión verbal como un componente significativo de la agresividad y sugieren que puede preceder a la agresión física en muchos casos(27).

Hostilidad

La hostilidad abarca un conjunto de actitudes y emociones negativas hacia los demás, que puede manifestarse a través de comportamiento y pensamientos destructivos, también se asocia a una reacción emocional que incluye sentimientos de cólera con actitudes que impulsan comportamientos agresivos hacia otros.(30)

Ira

La ira es una respuesta emocional que se activa ante situaciones percibidas como amenazantes o injustas, y puede intensificarse en entornos laborales, lo que a menudo lleva a comportamientos agresivos(29). Buss y Perry han señalado que la ira es un precursor de la agresión, ya que su intensidad y duración influyen significativamente en la propensión de una persona a actuar violentamente (27).

2.1.2.5 Violencia en el lugar de trabajo(WPV)

Se caracteriza como un evento en el cual una persona es objeto de abuso, agresión o amenaza en situaciones vinculadas a su ámbito profesional que abarca tanto el abuso verbal y física. (31)La violencia laboral en entornos de atención médica ha sido motivo de preocupación durante más de dos décadas (32) y ha crecido en importancia a nivel mundial en los últimos años (33)debido a que se ha visto un aumento de hechos de violencia y agresividad en el lugar de trabajo especialmente en médicos, enfermeras (34)

A pesar de que el WPV está en aumento en todo el mundo aún no hay un consenso exacto sobre la magnitud exacta de los problemas ya que varía según el país por ejemplo en Grecia es 76.0 % , en Italia 67% , 75% en Australia y 4.6% en Hong Kong (34)mientras que en China la prevalencia es de alrededor 65.8% (35).En el Perú según un estudio realizado en distintos hospitales de la capital, un 59.6% de los participantes reportó haber presenciado algún tipo violencia dirigida a sus colegas (8), esta variación en la prevalencia podría deberse a las distintas regulaciones y legislación que cada gobierno realiza sobre el WPV entre los países. Asimismo , la regulación de la WPV es menos efectiva en países en desarrollo en comparación con países desarrollados, lo que subraya la responsabilidad del empleador para garantizar el bienestar de los profesionales y

prevenir la violencia en el entorno laboral (34) así como sus consecuencias adversas como la insatisfacción laboral , errores médicos , disminución de la calidad de atención al usuario, problemas de salud mental (16) disminución de la productividad, aumento del ausentismo, aumento de los costos de consultoría y disminución de la moral del personal.(15)

Entre las distintas causas de WPV contra los trabajadores sanitarios podemos encontrar diferentes motivos , tales como el incumplimiento de procedimientos , por ejemplo, el triaje en urgencias y la solicitud de exámenes prioritarios en el ambulatorio.

En términos de problemas de comunicación, se observó que el manejo estresante de los usuarios en lugares como la sala de emergencias, clínicas ambulatorias, servicios quirúrgicos y UCI contribuyó significativamente.

En el departamento de urgencias, la insatisfacción surge con mayor frecuencia debido a las extensas colas de usuarios que se forman con el objetivo de ser atendidos, y la apatía percibida por parte del personal sanitario. Por otro lado, en la consulta externa, factores como la impaciencia del usuario , la inquietud y las largas colas para recibir servicios han sido identificados como causas predominantes.(15)

2.1.3 Definición de términos

-Factores desencadenantes: Factores asociados al comienzo de una enfermedad , accidente, respuesta a una conducta o curso de una acción. Generalmente uno de los factores es el más importante.(36)

-Irritabilidad: umbral bajo para experimentar la ira como respuesta a la frustración, de manera similar la violencia se define como el uso intencional de la fuerza física para dañar, herir o matar a alguien.(37)

-Agresividad: Es un componente de la conducta normal que se expresa para satisfacer necesidades esenciales y superar o eliminar amenazas que puedan afectar la integridad física o psicológica. Constituye una disposición a actuar de manera agresiva en diferentes situaciones, lo que incluye atacar, ofender, provocar o faltar el respeto de forma intencional.(37)

-Hostilidad: La hostilidad es un rasgo de la personalidad con componentes cognitivos, afectivos y conductuales. Incluye desconfianza, actitudes negativas hacia los demás, expresión de ira y desprecio que se refleja en un juicio desfavorable o negativo del otro. Implica conductas dirigidas a una meta que puede ser la destrucción o el daño físico de objetos o personas.(37)

-Agresión: Consiste en una conducta voluntaria, punitiva y destructiva dirigida a una meta concreta en respuesta a situaciones específicas llevada a cabo de forma adaptativa.(37)

-Ira: Se define como un estado emocional que va desde una leve molestia o enojo hasta una furia intensa, que surge frente a situaciones desagradables y no están dirigidos a una meta.(37)

-Violencia: Se refiere a conductas agresivas que van más allá de lo considerado natural o adaptativo y se destaca por su intensidad, destructividad y falta de justificación, a diferencia de la agresión, la violencia tiene un carácter ofensivo que puede violar los derechos humanos y suele ser ilegal por tanto carece de aprobación social.(37)

2.2 Formulación de la hipótesis

El estudio es de tipo descriptivo por ello no necesita la formulación de la hipótesis de la investigación

2.3 Diseño metodológico

2.3.1 Tipo de investigación

Este estudio es de tipo observacional descriptivo transversal. Es observacional, ya que permite identificar el nivel de agresividad de los

usuarios tal como ocurre naturalmente sin influir en su conducta. Es descriptivo ya que busca registrar el nivel de agresividad de los usuarios externos sin buscar una causa específica; aunque permite explorar algunos factores que estarían asociados, para poder examinarlos con mayor detalle en estudios analíticos futuros .Es transversal ya que los datos se recolectan una sola vez en el tiempo.

2.3.2 Población

La población de estudio consistirá en los usuarios externos que acuden al Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordan” , dentro del rango de edades comprendido entre los 18 y los 59 años, 11 meses y 29 días; que comprende las etapas de vida de joven y adulto.

La información proviene de los usuarios externos que recibieron atención en todos los servicios del establecimiento durante los últimos 12 meses, y fue proporcionada por la oficina de estadística del centro de salud. En base a esta información, se define la población de estudio.

Tabla 1: Distribución de la Población de Estudio por Género y Edad

Grupo de edad	Hombres (n)	Hombres (%)	Mujeres (n)	Mujeres (%)	Total (n)	Total (%)
18 - 24 años	8,500	7.62%	8,337	7.47%	16,837	15.09%
25 - 29 años	6,839	6.13%	7,027	6.30%	13,866	12.43%
30 - 34 años	7,402	6.64%	7,847	7.03%	15,249	13.67%
35 – 39 años	7,044	6.31%	7,642	6.85%	14,686	13.17%
40 – 44 años	7,162	6.42%	7,584	6.80%	14,746	13.22%
45 – 49 años	6,674	5.98%	7,016	6.29%	13,690	12.27%
50 – 54 años	5,589	5.01%	6,140	5.50%	11,729	10.52%
55 – 59 años	4,941	4.43%	5,801	5.20%	10,742	9.63%
TOTAL	54,151	48.55%	57,394	51.45%	111,545	100%

Fuente: Oficina de Estadística. Centro de Salud San Miguel 2025

La Tabla 1 muestra la distribución de la población de estudio según género y grupo de edad. La población total considerada es de 111,545 personas, distribuidas en diferentes rangos etarios. Los hombres representan el 48.55% de la población total (54,151 individuos), mientras que las mujeres constituyen el 51.45% (57,394 individuos).

2.3.2.1 Criterios de Inclusión:

- Usuarios externos que acuden al CS “San Miguel Manuel Bertorini Jordan”
- Usuarios externos cuya edad oscila entre 18 a 59 años, 11 meses y 29 días .
- Usuarios externos que acepten participar en el estudio y que hayan firmado el consentimiento informado para participar en el estudio

2.3.2.2 Criterios de exclusión:

- Usuarios externos que no hablan idioma castellano
- Usuarios externos que requieran asistencia de un familiar para responder
- Usuarios externos que no sepan leer o escribir

2.3.3 Muestra

Para calcular el tamaño de la muestra de estudio se emplea la fórmula de Cochran, la cual es una fórmula estándar para calcular el tamaño de muestra para una población infinita:

$$n = \frac{(Z)^2(p_e)(q_e)}{E^2}$$

$Z = 1,96$ (para un nivel de confianza del 95%)

$p_e = 0,5$ (se utiliza 0.5 como valor arbitrario al no tener antecedentes de una proporción de agresividad)

$q_e = 0,5$ (es la diferencia de 1 menos el valor de p)

$E = 0,05$ (es el margen de error deseado y se le asigna un valor pequeño como 0.05 para tener un intervalo de confianza más preciso)

$$n = \frac{(1.96)^2(0.5)(0.5)}{(0.05)^2} = 384$$

Por lo tanto, el tamaño de muestra requerido para una población infinita es aproximadamente 384.

Sin embargo, ya que conocemos la población de estudio, que es de 111545, se utiliza otra fórmula para ajustar el tamaño de la muestra (n_f). La fórmula de corrección para poblaciones finitas ajusta este tamaño para tener en cuenta la variabilidad reducida en una población finita, lo que evita el sobreajuste del tamaño de muestra.

$$n_f = \frac{n}{1 + \left(\frac{n}{N}\right)}$$

$n=384$

$N=22\ 069$

$$n_f = \frac{384}{1 + \left(\frac{384}{111545}\right)} = 383$$

Por lo tanto, el tamaño de muestra ajustado para la población finita es aproximadamente 383.

Por ende, para este estudio se requerirá una muestra de 383 usuarios del Centro de Salud de San Miguel.

2.3.4 Muestreo

Se realizará un muestreo no probabilístico por cuotas. Esto se debe a que los usuarios que acudan al Centro de Salud San Miguel "Manuel Bertorini Jordan" tendrán la posibilidad de participar en el estudio, y la muestra se estructurará en cuotas, de manera que cada grupo de edad esté representado proporcionalmente en la investigación. En este sentido, no toda la población que corresponde a la jurisdicción del centro de salud acude al mismo y, de los que acuden, probablemente no lo hacen con la misma frecuencia. Por lo tanto, al no tener todos los individuos de la población la misma probabilidad de participar, se aplicará este tipo de muestreo.

El muestreo será por cuotas, ya que se seleccionará a los participantes en estratos de acuerdo a edad y sexo, según la proporción de estas características en la población. Este tipo de muestreo permite controlar el sesgo de selección al asegurar que cada estrato esté adecuadamente representado. Para reducir aún más el sesgo, se captará a los usuarios de los distintos servicios médicos que ofrece el Centro de Salud, en diferentes turnos, de lunes a sábado, en la mañana o en la tarde.

El tamaño de la muestra será de 383 usuarios externos que acudan al centro de salud, y se dividirá en cuotas según los grupos de edad. Esta muestra es representativa de los usuarios del centro durante el periodo de estudio.

Tabla 2. Distribución del Muestreo por Grupo de edad y género

Grupo de edad en Muestra de estudio	Hombres		Mujeres		Total	
	(n)	(%)	(n)	(%)	(n)	(%)
18 - 24 años	29	7.62%	29	7.47%	58	15.09%
25 - 29 años	23	6.13%	24	6.30%	48	12.43%
30 - 34 años	25	6.64%	27	7.03%	52	13.67%

35 – 39 años	24	6.31%	26	6.85%	50	13.17%
40 – 44 años	25	6.42%	26	6.80%	51	13.22%
45 – 49 años	23	5.98%	24	6.29%	47	12.27%
50 – 54 años	19	5.01%	21	5.50%	40	10.52%
55 – 59 años	17	4.43%	20	5.20%	37	9.63%
TOTAL	186	48.55%	197	51.45%	383	100%

Fuente : Elaboración propia

La Tabla 2 muestra la distribución del muestreo por género y grupo de edad, con un total de 383 personas. Los hombres constituyen el 48.55% de la muestra (186 individuos) y las mujeres el 51.45% (197 individuos). El grupo de 18 a 24 años es el más numeroso, representando el 15.09% de la muestra, seguido por el grupo de 30 a 34 años con el 13.67%.

2.3.5 Operacionalización de variables

VARIABLE	DIMENSIÓN	INDICADORES	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	VALORES	TIPO DE VARIABLE/ ESCALA DE MEDICIÓN	TÉCNICA/ INSTRUMENTO DE MEDICIÓN
Características sociodemográficas	Características biosociales	Edad	Tiempo de vida de una persona desde su nacimiento	Edad en años consignada en la ficha de datos	años cumplidos	Cuantitativa/continua	Ficha de datos
		Género	Conjunto de características que diferencian al varón y a la mujer	Condición orgánica referida en la ficha de datos	Masculino, Femenino, otro	Cualitativa nominal	Ficha de datos
	Características socioculturales	Ocupación	Trabajo al cual se dedica la persona	Estado de ocupación consignado en la encuesta	Profesional de la salud, profesional de otro rubro, técnico, otro	Cualitativa nominal	Ficha de datos
		Grado de instrucción	Grado de estudios que alcanzó	Grado de instrucción más alto referido en la ficha de datos	Sin instrucción, primaria, secundaria, Superior	Cualitativa/ordinal	Ficha de datos
Tiempo de espera percibido	Tiempo de espera percibido	Duración en minutos	Duración desde la llegada al establecimiento de salud, hasta recibir la atención médica	Tiempo en minutos entre ingresar al establecimiento de salud hasta ingresar a la consulta	Minutos	Cuantitativa/continua	Ficha de datos

Capacidad de comunicación del médico percibida por los usuarios	Relación paciente-médico	Calidad de comunicación	Capacidad de expresar conceptos de forma efectiva, respetuosa y oportuna	Percepción de la capacidad de comunicación de los médicos por parte de los usuarios	No me explica bien (Inadecuada) A veces no me explica bien (Poco adecuada) Me explica bien (Adecuada) Me explica muy bien (Muy adecuada)	Cualitativa/ordinal	Ficha de datos
Triaje	Cumplimiento de procedimientos	Cumplimiento de procedimientos de toma de signos vitales	Clasificación de pacientes según su estado de salud (triage)	Percepción de los usuarios sobre el cumplimiento de los procedimientos de triage	Sí, cumplieron, Más o menos cumplieron, No cumplieron	Cualitativa/ordinal	Ficha de datos
	Manejo de comunicación cuando el paciente pasa por situaciones tensas	Efectividad de la comunicación en momentos de estrés	Problemas de comunicación (manejo estresante del usuario)	Evaluación sobre el manejo de la comunicación entre el personal de salud y los usuarios en situación de estrés	Muy bien, bien, regular, mal	Cualitativa/ordinal	Ficha de datos

Problemas de comunicación	Claridad en la información	Grado de comprensión del usuario sobre su tratamiento	Falta de claridad en la comunicación	Evaluación sobre la comprensión del usuario acerca del tratamiento, diagnóstico y procedimientos	Muy clara, clara, poco clara, nada clara	Cualitativa/ordinal	Ficha de datos
	Empatía y trato adecuado	Nivel de empatía percibido	Empatía y trato adecuado por parte del personal médico	Evaluación del nivel de empatía y trato adecuado percibido por los usuarios por parte del personal médico	Siempre me entiende y me trata bien, Me entiende y me trata bien, A veces no me entiende ni me trata bien, Nunca me entiende ni me trata bien		Ficha de datos
Insatisfacción	Insatisfacción general	Nivel de insatisfacción respecto a colas y tiempos de espera	Insatisfacción (colas, apatía, impaciencia, inquietud)	Evaluación del nivel de insatisfacción por las largas colas y la actitud de los trabajadores sanitarios	Muy contento/a, contento/a, No muy contento/a, Para nada contento/a	Cualitativa/ordinal	Ficha de datos
Manejo de situaciones de estrés por parte del personal de salud	Habilidad del personal	Percepción sobre la habilidad del personal en situaciones estresantes	Gestión estresante de los usuarios en la sala de emergencias	Percepción de la habilidad del personal para manejar situaciones de estrés con los usuarios en emergencias*	Muy bien, bien, más o menos, mal	Cualitativa/ordinal	Ficha de datos

Disponibilidad para conseguir citas	Facilidad para obtener citas	Accesibilidad para agendar una cita médica	Percepción del usuario sobre la facilidad o dificultad para obtener una cita médica	Evaluación del usuario sobre los pasos para obtener una cita	Muy fácil, Fácil, Difícil, Muy difícil	Cualitativa/ordinal	Ficha de datos
Historia clínica	Disponibilidad de la historia clínica	Frecuencia con la que la historia clínica está disponible	Disponibilidad de la historia clínica para la atención médica	Evaluación sobre la percepción del usuario respecto a si su historia clínica estaba disponible en el consultorio para la consulta médica.	Siempre, a veces, Nunca	Cualitativa/ordinal	Ficha de datos

Niveles de agresividad	Nivel de agresividad	Puntaje total en cuestionario	Inclinación que siente una persona a realizar un acto agresivo	Puntuación obtenida en el cuestionario de Buss y Perry (preguntas 1 a 29).Escala likert del 1 al 5	Muy Alto: ≥ 99 Alto: 83 - 98 Medio: 68 - 82 Bajo: 52 - 67 Muy bajo: <51	Cualitativa/ordinal	Adaptación peruana del cuestionario de Buss y Perry
	Nivel de agresión física	Puntaje en subescala de agresión física	Uso intencional de la fuerza contra otra persona, usando una parte del cuerpo u objetos	Puntuación obtenida en el cuestionario de Buss y Perry (preguntas 1,5,9,13,17,21,24, 27).Escala likert del 1 al 5	Muy Alto: 30 a más Alto: 24 - 29 Medio: 16 - 23 Bajo: 12 - 17 Muy bajo: menos a 11	Cualitativa/ordinal	Adaptación peruana del cuestionario de Buss y Perry
	Nivel de agresión verbal	Puntaje en subescala de agresión verbal	Tipo de agresión en la cual se pretende dañar a las personas por medio del discurso	Puntuación obtenida en el cuestionario de Buss y Perry (preguntas 2,6,10,14,18).Escala likert del 1 al 5	Muy Alto: 18 a más Alto: 14 - 17 Medio: 11 - 13 Bajo: 7 - 10 Muy bajo: menos a 6	Cualitativa/ordinal	Adaptación peruana del cuestionario de Buss y Perry
	Nivel de ira	Puntaje en subescala de ira	Reacción de irritación, furia o cólera inducida por la indignación al sentir vulnerados nuestros derechos	Puntuación obtenida en el cuestionario de Buss y Perry (preguntas 3,7,11,15,22,25).Escala likert del 1 al 5	Muy Alto: 27 a más Alto: 22 - 26 Medio: 18 - 21 Bajo: 13 - 17 Muy bajo: menos a 12	Cualitativa/ordinal	Adaptación peruana del cuestionario de Buss y Perry
	Nivel de hostilidad	Puntaje en subescala de hostilidad	Evaluación negativa acerca de las personas y las cosas	Puntuación obtenida en el cuestionario de Buss y Perry (preguntas 4,8,12,16,20,23,26).Escala likert del 1 al 5	Muy Alto: 32 a más Alto: 26 - 31 Medio: 21 - 25 Bajo: 15 - 20 Muy bajo: menos a 14	Cualitativa/ordinal	Adaptación peruana del cuestionario de Buss y Perry

2.3.6 Técnica e instrumento de recolección de datos

Los datos se obtendrán a partir de la aplicación de cuestionarios a usuarios que acuden al Centro de Salud.

El Cuestionario de Agresión(AQ), desarrollado a partir de las investigaciones de Buss y Perry en 1992, evalúa cuatro dimensiones principales de la agresividad.

- La agresión física: Compuesta por 9 ítems, que corresponden a los números 1, 5, 9, 13, 17, 21, 24, 27 y 29
- Agresión Verbal: Incluye 5 ítems, que son los números 2, 6, 10, 14 y 18.
- Ira: Compuesta por 7 ítems, correspondientes a los números 3, 7, 11, 15, 19, 22 y 25.
- Hostilidad: Incluye 8 ítems, que corresponden a los números 4, 8, 12, 16, 20, 23, 26 y 28.

En total, el cuestionario consta de 29 ítems que abordan diferentes sentimientos y comportamientos agresivos. Cada ítem se evalúa utilizando una escala tipo Likert de cinco puntos, que va desde 1 (completamente falso para mí) hasta 5 (completamente verdadero para mí)(27,38).

A continuación, el Cuestionario de Agresión (AQ) de Buss y Perry adaptado en el estudio de Matalinares et al (38)

INSTRUCCIONES

A continuación se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo un aspa“X”según la alternativa que mejor describa tu opinión.

CF = Completamente falso para mí

BF = Bastante falso para mí

VF= Ni verdadero, ni falso para mí

BV = Bastante verdadero para mí

CV = Completamente verdadero para mí

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma como tú percibes, sientes y actúas en esas situaciones.

	CF	BF	VF	BV	CV
01. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra persona					
02. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto abiertamente con ellos					
03. Me enoja rápidamente, pero se me pasa en seguida					
04. A veces soy bastante envidioso					
05. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona					
06. A menudo no estoy de acuerdo con la gente					
07. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo					
08. En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente					
09. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también					
10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos					
11. Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto de estallar					
12. Parece que siempre son otros los que consiguen las oportunidades					
13. Suelo involucrarme en la peleas algo más de lo normal					
14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar discutir con ellos					
15. Soy una persona apacible					
16. Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por algunas cosas					
17. Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, lo hago					
18. Mis amigos dicen que discuto mucho					
19. Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva					
20. Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas					
21. Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a pegarnos					
22. Algunas veces pierdo el control sin razón					
23. Desconfío de desconocidos demasiado amigables					
24. No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona					
25. Tengo dificultades para controlar mi genio					
26. Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas					
27. He amenazado a gente que conozco					
28. Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto qué querrán					
29. He llegado a estar tan furioso que rompía cosas					

A continuación se presenta una tabla que resume las dimensiones del cuestionario de Agresión(AQ) de Buss y Perry, tal como se adapta en el estudio de Matalinares et al. (38)

	ESCALA	SUB ESCALAS			
	AGRESIÓN	Agresividad Física	Agresividad Verbal	Ira	Hostilidad
Muy Alto	99 a Más	30 a Más	18 a Más	27 a Más	32 a Más
Alto	83 – 98	24 – 29	14 – 17	22 – 26	26 – 31
Medio	68 – 82	16 – 23	11 – 13	18 – 21	21 – 25
Bajo	52 – 67	12 – 17	7 – 10	13 – 17	15 – 20
Muy Bajo	Menos a 51	Menos a 11	Menos a 6	Menos a 12	Menos a 14

Este cuadro, adaptado del estudio de Matalinares et al. (2012), ilustra las diferentes categorías de agresión y permite a los investigadores clasificar la frecuencia y la intensidad de estas conductas en los sujetos evaluados.

En el proceso de adaptación del AQ, Andreu, Peña y Graña (2002) llevaron a cabo un estudio psicométrico con una población española, logrando así adaptar el cuestionario a la versión española. Este esfuerzo de validación ha facilitado el uso del AQ en diversas culturas y contextos. (39)

La escala AQ ha sido traducida y aplicada en numerosos países gracias a su accesibilidad y costos reducidos. Se ha llevado a cabo investigaciones sobre su estructura factorial en diversos idiomas y culturas como el japonés, ruso, alemán, holandés y francés .(40-45).En América Latina, el cuestionario ha sido validado en varios países, incluyendo Colombia, Argentina, El Salvador, México, Chile y Perú, obteniendo resultados favorables y niveles aceptables de consistencia interna (38,46-50).

En Perú, María Matalinares y Juan Yaringaño en el 2012 llevaron a cabo la adaptación de la versión española del cuestionario de Agresión a la realidad peruana. Este estudio se realizó con una muestra de 3632 individuos de 10 a 19 años , de ambos sexos, pertenecientes a los grados de 1° a 5° de secundaria procedentes de distintas instituciones educativas de la costa, sierra y selva del Perú. Este estudio analiza la estructura del cuestionario a

través de un análisis factorial exploratorio con lo cual se demuestra una consistencia interna aceptable. Asimismo, los autores clasifican la agresividad por niveles, desde muy bajo a muy alto.(38)

García-Batista y colaboradores publicaron un estudio en 2022 con el objetivo de validar el Cuestionario de Agresividad (AQ) en la población adulta argentina. Desarrollaron una cohorte de 799 participantes, en la que el 65.8% eran mujeres, seleccionados a partir de un muestreo no probabilístico accidental cuya edad media fue de 29.36 años.

Los autores compararon diferentes modelos factoriales, encontrando que el modelo de tres factores (hostilidad, violencia verbal y violencia física) presentó el mejor ajuste. Los niveles de consistencia interna resultaron óptimos, con valores α entre .88 y .79. Además, se observaron correlaciones significativas entre las puntuaciones del AQ y la intolerancia a la frustración, lo que refuerza la validez del instrumento en esta población. Concluyeron que el AQ es una herramienta válida y confiable para evaluar la agresividad en adultos argentinos, y que los hallazgos tienen importantes implicancias tanto teóricas como prácticas en el contexto latinoamericano.(47)

2.3.7 Procedimiento para la recolección de datos

Los datos serán registrados en la ficha de recolección de datos del presente proyecto (ver Anexo 1). Se utilizará la versión adaptada del Cuestionario de Buss y Perry, ajustada para el contexto peruano, para la recopilación de información. La recolección de datos será realizada por personal capacitado, específicamente estudiantes de medicina, quienes apoyarán en este proceso. Los datos se recopilarán en diferentes sitios, incluyendo triaje y consultorios de medicina. La recolección se llevará a cabo en horarios variados, tanto en la mañana como en el turno de la tarde, de lunes a sábado. Los datos recolectados serán ingresados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel para su organización y almacenamiento. Posteriormente, se procederá al análisis estadístico empleando el software STATA versión 14.2, con el objetivo de obtener los resultados necesarios para la investigación.

2.3.8 Análisis estadístico de los datos

En primer lugar, se llevará a cabo un análisis descriptivo de los datos. Las variables que son de naturaleza categórica serán descritas mediante el uso de frecuencias absolutas y relativas. Por otro lado, las variables cuantitativas serán descritas utilizando medidas de tendencia central y dispersión. Este análisis será presentado en forma de tabla como parte del análisis univariado. Luego se realizará un análisis bivariado para la relación entre el nivel de agresividad, sus dimensiones y las demás variables.

Para identificar la relación entre el nivel de agresividad y sus dimensiones se realizará un análisis bivariado mediante la prueba de Chi Cuadrado y el Test exacto de Fisher para variables categóricas, y para las variables cuantitativas se utilizará la prueba de T de Student si siguen una distribución normal o una prueba de ANOVA si no siguen una distribución normal.

2.3.9 Consideraciones éticas

El presente estudio se comprometerá a preservar la confidencialidad de la información recopilada. Para ello, se asignarán códigos a cada cuestionario de los participantes, los cuales serán empleados en la base de datos correspondiente.

Esta base de datos será completada en un archivo Excel protegido por una clave de seguridad para su acceso. Previo a la ejecución del estudio, tanto este protocolo como el documento de recolección de datos serán sometidos a la evaluación y aprobación por parte del Director del Centro de Salud y el Comité de Ética de la Dirección de Redes Integradas de Salud - DIRIS Lima Centro.

CAPÍTULO III:

3.1 Cronograma del trabajo

[illegible]

3.2 Presupuesto

El presupuesto total es de S/1,100 y está distribuido de la siguiente manera:

1.Recursos Humanos:

- Se ha considerado un gasto de S/ 100 para los colaboradores que estarán encargados de la recolección de datos y S/ 500 para el análisis de los mismos.
- Subtotal: S/ 600

2.Recursos Materiales

- Se asignaron S/ 100 para las copias necesarias en el proceso de recolección de datos
- Subtotal:S/ 100

3.Servicios

- Los costos incluyen S/ 100 por el servicio de internet, S/100 por el consumo de electricidad, y S/ 200 destinados al transporte.
- Subtotal: S/ 400

	CANTIDAD	COSTO	TIEMPO	TOTAL
RECURSOS HUMANOS				
Colaboradores en recolección de datos	5	S/.20	20 días	S/.100
Análisis de datos	1	S/.500	20 días	S/.500

RECURSOS MATERIALES				
Copias para ficha de recolección de datos	200	S/.0.5	9 meses	S/.100
SERVICIOS				
Servicio de internet	100GB	S/.100	9 meses	S/.100
Servicio eléctrico	100 w	S/.100	9 meses	S/.100
Transporte	40	S/.5	9 meses	S/.200
PRESUPUESTO TOTAL	S/.1100			

3.3 Recursos disponibles

- **Recursos humanos**

-Recolectores de datos : 4 personas , estudiantes de medicina que cuentan con conocimientos en investigación

-Análisis de datos : 4 personas , estudiantes de medicina que cuentan con conocimiento en investigación, tesista , asesor.

En caso se requiera análisis complejos se contactará con un especialista en Metodología de investigación.

- **Recursos Materiales**

Copias para fichas de recolección de datos

- **Servicios**

-Servicio de internet :servicio que se usa en la búsqueda bibliográfica , redacción de protocolo y análisis de resultados.

-Servicio eléctrico : servicio que se usa junto a laptops y equipos electrónicos implicados en la realización de este proyecto.

-Transporte : desde la facultad de Medicina de San Fernando hacia el CS."San Miguel Manuel Bertorini Jordan"

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Liu J, Gan Y, Jiang H, Dwyer R, Lu K, et al. Prevalence of workplace violence against healthcare workers: a systematic review and meta-analysis. *Occup Environ Med*. 2019;76(12):927-37.
2. National Collaborating Centre for Mental Health (UK). Violence and aggression: short-term management in mental health, health and community settings: updated edition. London: British Psychological Society (UK); 2015. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK305020/>
3. Ramacciatì N, Gili A, Mezzetti A, Ceccagnoli A, Addey B, Rasero L. Violence towards Emergency Nurses: The 2016 Italian National Survey. A cross-sectional study. *J Nurs Manag*. 2019 ;27(4):792–805.
4. World Health Organization. Occupational hazards in health sector: Violence & harassment [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2023. Disponible en: <https://www.who.int/tools/occupational-hazards-in-health-sector/violence-harassment>.
5. Rodríguez Campo VA, Paravic Klijn TM, González Rubilar UD. Percepción de violencia física y factores asociados en profesionales y técnicos paramédicos en la atención prehospitalaria. *Index Enferm*. 2015;24(1):4-10.
6. da Silva ATC, Peres MFT, Lopes CS, et al. Violence at work and depressive symptoms in primary health care teams: a cross-sectional study in Brazil. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*. 2015;50(9):1347-55.

7. Agueda Muñoz del Carpio Toia C, Muñoz del Carpio-Toia A, Valdivia-Fernández B, et al. Violencia hacia los médicos en hospitales de Arequipa, Perú, 2016. Acta Med Peru. 2016;33(2):97-102. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v33n2/a02v33n2.pdf>
8. Tuya-Figueroa X, Mezones-Holguín E, Monge E, et al. Violencia laboral externa tipo amenaza contra médicos en servicios hospitalarios de Lima Metropolitana, Perú 2014. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2016;33(4):670-79.
9. Fritz M, Soravia SM, Dudeck M, Malli L, Fakhoury M. Neurobiology of Aggression: Review of Recent Findings and Relationship with Alcohol and Trauma. Biology (Basel)2023;12(3):469. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36979161/>
10. Chester DS. Aggression as successful self-control. Soc Personal Psychol Compass 2024;18(2). Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/spc3.12832>.
11. ScienceDaily. Crueldad controlada: un nuevo estudio descubre que la agresión puede surgir de un autocontrol exitoso [Internet]. 2023 Jul 13. Disponible en: <https://www.sciencedaily.com/releases/2023/07/230713141930.htm>
12. Ministerio de Salud, DIRIS Lima Centro. Directorio Establecimientos - DIRIS Lima Centro [Internet].2024. Disponible en: <https://dirislimacentro.gob.pe/directorio-establecimientos/>
13. Pina D, López-Ros P, Luna-Maldonado A, Luna Ruiz-Caballero A, Llor-Esteban B, Ruiz-Hernández JA, García-Jiménez JJ, Puente-López E, Martínez-Jarreta B. Users' perception of violence and conflicts with professionals in primary care centers before and during COVID-19: a qualitative study. Front Public Health. 2021;9:810014.

14. Pina D, Peñalver-Monteagudo CM, Ruiz-Hernández JA, Rabadán-García JA, López-Ros P, Martínez-Jarreta B. Sources of conflict and prevention proposals in user violence toward primary care staff: a qualitative study of the perception of professionals. *Front Public Health*. 2022;10:862896.
15. Sari H, Yildiz İ, Çağla Baloğlu S, Özel M, Tekalp R. The frequency of workplace violence against healthcare workers and affecting factors. *PLoS One*. 2023 Jul 1;18(7).
16. Yang Y, Li Y, An Y, Zhao YJ, Zhang L, Cheung T, et al. Workplace violence against Chinese frontline clinicians during the COVID-19 pandemic and its associations with demographic and clinical characteristics and quality of life: A structural equation modeling investigation. *Front Psychiatry*. 2021 Apr 15;12:664353.
17. Haider N, Ansari MSH, Anjum MZ, Nawaz A, Mustafa S, Qureshi MA. Violence and aggression towards healthcare workers: A study conducted in a tertiary care hospital in Pakistan. *Pak J Med Health Sci*. 2020;14(4):964-66. Disponible en : <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85099215070&partnerID=40&md5=1dd5d58afb9524932832a448030325bc>.
18. Pompeii L, Benavides E, Pop O, Rojas Y, Emery R, Delclos G, et al. Workplace violence in outpatient physician clinics: A systematic review. *Int J Environ Res Public Health*. 2020;17(18):1-13.
19. Sun T, Gao L, Li F, Shi Y, Xie F, Wang J, et al. Workplace violence, psychological stress, sleep quality and subjective health in Chinese doctors: A large cross-sectional study. *BMJ Open*. 2017 Dec 1;7(12).

20. Bravo E, Baez AN, Cozzoli BC, Auchter MC, Meza AM. Situaciones de violencia por parte de pacientes percibidos por personal de enfermería en un hospital público de Corrientes capital 2021. *Notas Enferm.* 2022;23(40):15-25. Disponible en : <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/notasenf/article/view/39590>
21. Agueda Muñoz del Carpio Toia C, Muñoz del Carpio-Toia A, Valdivia-Fernández B, Velasquez-Lazo C, Valdivia-Rodríguez M, Arroyo-Tovar GY, et al. Violencia hacia los médicos en hospitales de Arequipa, Perú, 2016. *Acta Med Peru.* 2016;33(2):97-102. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v33n2/a02v33n2.pdf>
22. Matalinares M, Yaringaño J, Uceda J, Fernández E, Huari Y, Campos A, et al. Estudio psicométrico de la versión española del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry. *Rev Investig Psicol.* 2012;15(1):147-61.
23. Weltens I, Bak M, Verhagen S, Vandenberg E, Domen P, van Amelsvoort T, et al. Aggression on the psychiatric ward: Prevalence and risk factors. A systematic review of the literature. *PLoS One.* 2021 Oct 1;16(10)
24. Camus D, Gholam M, Conus P, Bonsack C, Gasser J, Moulin V. Facteurs individuels et contextuels participant à l'apparition de comportements violents en cours d'hospitalisations psychiatriques. *Encéphale.* 2022 Apr 1;48(2):155-162.
25. Abbiati M, Golay P, De Maria LF, Palix J, et al. Measuring the severity of objective and subjective patient-to-staff violence in psychogeriatric and adult psychiatric wards: A retrospective study of four Swiss hospitals. *Issues Ment Health Nurs.* 2023;44(11):1142-49. Disponible en : <https://doi.org/10.1080/01612840.2023.2246560>.

26. World Health Organization. Occupational hazards in health sector: Violence & harassment [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2023. Disponible en: <https://www.who.int/tools/occupational-hazards-in-health-sector/violence-harassment>
27. Buss AH, Perry M. The aggression questionnaire. *J Pers Soc Psychol.* 1992;63(3):452-59. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1403624/>
28. The Joint Commission. Sentinel Event Alert. Workplace Violence [Internet]. Oakbrook Terrace (IL): The Joint Commission; 2018. Disponible en: https://www.jointcommission.org/assets/1/6/SEA_59_Workplace_Violence_FINAL2.pdf
29. International Labour Organization. Violence at work. 3rd ed. Geneva: International Labour Organization; 2016. Disponible en: <https://www.ilo.org/publications/violence-work-3rd-edition>.
30. Moscoso M. La hostilidad: Sus efectos en la salud y medición psicométrica en Latinoamérica. *Persona.* 2008;11:75-90. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=147117608005>
31. Giménez Lozano JM, Martínez Ramón JP, Morales Rodríguez FM. Doctors and nurses: A systematic review of the risk and protective factors in workplace violence and burnout. *Int J Environ Res Public Health.* 2021 Mar 2;18(6):302
32. Kobayashi Y, Oe M, Ishida T, Matsuoka M, Chiba H, Uchimura N. Workplace violence and its effects on burnout and secondary traumatic stress among mental healthcare nurses in Japan. *Int J Environ Res Public Health.* 2020 Apr 2;17(8):2747.

33. Climent-Rodríguez JA, Navarro-Abal Y, García-Iglesias JJ, Vaca-Acosta RM, Ortega-Moreno M, Gómez-Salgado J. Violencia en el trabajo y compromiso laboral en los profesionales de enfermería en España: un estudio transversal. *Rev Esp Salud Pública*. 2023;97:1-9
34. Varghese A, Joseph J, Vijay VR, Khakha DC, Dhandapani M, Gigini G, et al. Prevalence and determinants of workplace violence among nurses in the South-East Asian and Western Pacific Regions: a systematic review and meta-analysis. *J Clin Nurs*. 2021;10:1-22.
35. Shi L, Zhang D, Zhou C, Yang L, Sun T, Hao T, et al. A cross-sectional study on the prevalence and associated risk factors for workplace violence against Chinese nurses. *BMJ Open*. 2017 Jun 1;7(6):2-5
36. BIREME. Estrés Psicológico [Internet]. *Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS)*; 2023. Disponible en: <https://decs.bvsalud.org/es/ths/resource/?id=24839>
37. Carrasco Ortiz MA, González Calderón MJ. Aspectos conceptuales de la agresión: definición y modelos explicativos. *Acción Psicológica*. 2006;4(2):7-38.
38. Matalinares M, Yaringaño J, Uceda J, Fernández E, Huari Y, Campos A, et al. Estudio psicométrico de la versión española del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry. *Rev Investig Psicol*. 2012;15(1):147-161.
39. Andreu JM, Peña ME, Graña JL. Adaptación psicométrica de la versión española del Cuestionario de Agresión de Buss y Perry. *Psicothema*. 2002;14(2):476-82.
40. Nakano K. Psychometric evaluation on the Japanese adaptation of the Aggression Questionnaire. *Behav Res Ther*. 2001;39(7):853-58.

41. Ruchkin VV, Eisemann M. Aggression and psychological problems in juvenile male delinquents versus controls in Russia: Alternative ways of "letting off steam"? *Aggress Violent Behav.* 2000 Mar-Apr;5(2):217-25.
42. von Collani G, Werner R. Self-related and motivational constructs as determinants of aggression. An analysis and validation of a German version of the Buss-Perry Aggression Questionnaire. *Pers Individ Dif.* 2005 May;38(7):1631-43.
43. Meesters C, Muris P, Bosma H, Schouten E, Beuving S. Psychometric evaluation of the Dutch version of the Aggression Questionnaire. *Behav Res Ther.* 1996;34(10):839-43.
44. Albouza Y, Chazaud P. French validation of the Competitive Aggressiveness and Anger Scale (FVCAAS). *Psychol Fr.* 2019;66(4):175-184.
45. Fossati A, Maffei C, Acquarini E, Di Ceglie A. Análisis factorial y de componentes confirmatorios multigrupo de la versión italiana del Cuestionario de Agresión. *Rev Eur Eval Psicol.* 2003;19(1):54-65.
46. Castrillón DA, Ortiz PA, Vieco F. Cualidades paramétricas del cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry en estudiantes universitarios de la ciudad de Medellín. *Rev Fac Nac Salud Pública.* 2004;22(2):49-61.
47. García-Batista ZE, Moretti LS, Franco P, Medrano LA, Mustaca AE. Validity and Reliability of the Aggression Questionnaire (AQ) for Argentine Adults. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica.* 2022;1(62):17-28.
48. Sierra JC, Gutiérrez Quintanilla JR. Validación de la versión española del Cuestionario de Agresión de Buss-Perry en estudiantes universitarios salvadoreños. *Psicol Salud.* 2007;17(1):103-13.

49. Pérez Matías OM, Ortega Andrade NA, Rincón Arenas AB, García Cruz R, Romero Ramírez MA. Propiedades psicométricas del Cuestionario de agresión en dos muestras diferentes de Hidalgo, México. *Eur Sci J*. 2013;9(32):107-20
50. Valdivia-Peralta M, Fonseca-Pedrero E, González-Bravo L, Lemos-Giráldez S. Propiedades psicométricas de la Escala de Agresividad AQ en estudiantes chilenos. *Psicothema*. 2014;26(1):39-46.

ANEXOS

ANEXO 1 MATRIZ DE CONSISTENCIA

NIVEL Y FACTORES ASOCIADOS CON LA AGRESIVIDAD DE LOS USUARIOS EXTERNOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL "MANUEL BERTORINI JORDAN" 2025

PROBLEMA	OBJETIVOS	MARCO TEÓRICO	VARIABLES	Indicador/es	METODOLOGÍA
¿Cuál es el nivel de agresividad y sus factores asociados con agresividad en los usuarios externos que acuden al CS San Miguel "Manuel Bertorini Jordan" 2025	General: Determinar el nivel de agresividad y sus factores asociados en usuarios externos que acuden al CS San Miguel "Manuel Bertorini Jordan" 2025 Específicos: -Determinar el nivel de agresión de la dimensión agresión física de los usuarios externos que acuden al CS San Miguel "Manuel Bertorini Jordan" en el 2025, según nivel de agresividad. -Determinar el nivel de agresión de la dimensión agresión verbal de los usuarios externos que acuden al CS San Miguel "Manuel Bertorini Jordan" en el 2025, según nivel de agresividad. -Determinar el nivel de agresión de la dimensión ira de los usuarios externos que acuden al CS San Miguel "Manuel Bertorini Jordan" en el 2025, según nivel de agresividad. -Determinar el nivel de agresión de la dimensión hostilidad de los usuarios externos que acuden al CS San Miguel "Manuel Bertorini Jordan" en el 2025, según nivel de agresividad. -Identificar los factores asociados con el nivel de agresividad y sus dimensiones de los usuarios externos que acuden al CS San Miguel "Manuel Bertorini Jordan" en el 2025, en la muestra	Antecedentes: -Tao Sun 2017 -Hidir Sari 2023 -Yuan Yang 2021 -Lisa Pompeii 2020 -Naveed Haider 2019 -D. Bravo 2021 -Tuya - Figueroa 2016 -Agueda Muñoz del Carpio-Toia 2016 Bases teóricas: -Agresividad -Acto violento -Teoría de la agresividad como rasgo universal -Dimensiones de la agresividad -Violencia en el lugar de trabajo	Nivel de Agresividad	-Nivel de agresividad -Nivel de agresión física -Nivel de agresión verbal -Nivel de ira -Nivel de hostilidad	Tipo de investigación Estudio observacional descriptivo Diseño Transversal Correlacional Población y muestra Población Usuarios externos que acuden al CS San Miguel Manuel Santorini Jordan Muestra 383 usuarios Muestreo No probabilístico, por cuotas Técnicas de recolección de datos Aplicación de cuestionario Instrumento Cuestionario de Agresión de Buss y Perry Análisis estadístico Estadística descriptiva -Univariado : Frecuencia para variables categóricas ; media y desviación estándar para cuantitativas con distribución normal ,mediana y rango intercuartílico para cuantitativas con distribución no normal -Bivariado: Chi Cuadrado para variables categóricas,t de Student para cuantitativo con distribución normal o Anova para cuantitativo con distribución no normal.
			Factores asociados	-Edad -Sexo -Ocupación -Grado de instrucción -Satisfacción con el cumplimiento de triaje -Tiempo de espera percibido -Capacidad de comunicación del médico percibido por los usuarios -Triaje -Problemas de comunicación -Insatisfacción -Manejo de situaciones de estrés por parte del personal de salud -Disponibilidad para conseguir citas -Historia clínica	

ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

FICHA DE DATOS

MARCA CON UNA “X” EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE A CADA OPCIÓN

I. FACTORES ASOCIADOS A AGRESIVIDAD

Edad (años):

Género: Femenino() Masculino () Otro ()

Grado de instrucción: Sin instrucción () Primaria () Secundaria () Superior

Ocupación: Profesional de la salud () Profesional de otro rubro () Técnico () Otro ()

Tiempo de espera percibido (minutos):

Capacidad de comunicación del médico percibida por los usuarios:

¿Qué tanto entendió la información del profesional?

No me explica bien (Inadecuada) ()

A veces no me explica bien (Poco adecuada) ()

Me explica bien (Adecuada) ()

Me explica muy bien (Muy adecuada) ()

Triaje:

¿Cumplieron con tomarte bien el peso, la talla y la presión arterial?

Sí, cumplieron () Más o menos cumplieron () No cumplieron ()

Problemas de comunicación:

¿Cómo evalúas la comunicación del personal que te atendió cuando estabas tenso(a) o preocupado(a)?

Muy bien () Bien () Regular () Mal ()

¿Cómo evalúas la información y explicaciones que te brindan sobre tu diagnóstico, tratamiento y procedimientos?

Muy clara () Clara () Poco clara () Nada clara ()

¿Cómo evalúas el trato y comprensión del personal que te atendió?

Siempre me entiende y me trata bien ()

Me entiende y me trata bien ()

A veces no me entiende ni me trata bien ()

Nunca me entiende ni me trata bien ()

¿Cómo evalúas tu nivel de satisfacción con el servicio recibido en términos de colas, tiempo de espera y actitud del personal que te atiende?

Muy contento/a (), Contento/a (), No muy contento/a (), Para nada contento/a ()

¿Cómo evalúa la habilidad del personal que lo atendió en situaciones estresantes?

Muy bien (), Bien (), Más o menos (), Mal ()

¿Cómo es el proceso para sacar citas? Muy fácil () Fácil () Difícil ()
Muy difícil ()

¿Tienen tu historia médica disponible cuando pides y recibes la atención? Siempre () a veces () nunca ()

II. CUESTIONARIO DE AGRESIÓN (AQ)

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones que podrían ocurrirle al momento en el que recibe la atención en el Centro de Salud .A las que deberá contestar escribiendo un aspa "X" según la alternativa que mejor describa su opinión.

CF = Completamente falso para mí; BF = Bastante falso para mí ; VF= Ni verdadero, ni falso para mí ; BV = Bastante verdadero para mí ; CV = Completamente verdadero para mí

Recuerda que no hay respuestas buenas o malas, sólo interesa conocer la forma como tú percibes, sientes y actúas en esas situaciones.

	CF	BF	VF	BV	CV
01. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a otra persona					
02. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto abiertamente con ellos					
03. Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida					
04. A veces soy bastante envidioso					
05. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona					
06. A menudo no estoy de acuerdo con la gente					
07. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo					
08. En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente					
09. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también					
10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos					
11. Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto de estallar					
12. Parece que siempre son otros los que consiguen las oportunidades					
13. Suelo involucrarme en las peleas algo más de lo normal					
14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar discutir con ellos					
15. Soy una persona apacible					
16. Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por algunas cosas					
17. Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, lo hago					
18. Mis amigos dicen que discuto mucho					
19. Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva					
20. Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas					
21. Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a pegarnos					
22. Algunas veces pierdo el control sin razón					
23. Desconfío de desconocidos demasiado amigables					
24. No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona					
25. Tengo dificultades para controlar mi genio					
26. Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis espaldas					
27. He amenazado a gente que conozco					
28. Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me pregunto qué querrán					
29. He llegado a estar tan furioso que rompía cosas					

Figura 1. Cuestionario de Agresión (AQ)

Fuente: Matalinares MC, Yaringaño LJ, Uceda EJ, Fernández EA, Huari TY, Campos AG, et al. Estudio psicométrico de la versión española del cuestionario de agresión de Buss y Perry. Rev Investig Psicol. 2012;15(1):147-61.

ANEXO 3 CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ESTUDIO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

TÍTULO DEL PROYECTO: Nivel y Factores asociados con la agresividad de los usuarios externos que acuden al Centro de Salud San Miguel “Manuel Bertorini Jordan”2024

INVESTIGADOR Y RESPONSABLE DEL ESTUDIO: Valencia Rivera ,Miriam

PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: El presente estudio tiene como objetivo determinar el nivel de agresividad y sus factores asociados en usuarios externos que acuden al CS San Miguel “Manuel Bertorini Jordan “ 2024

PARTICIPACIÓN: Si usted acepta participar en el estudio de investigación, se le solicitará completar un cuestionario sobre su nivel de agresividad.

RIESGOS Y BENEFICIOS: El estudio no conlleva ningún riesgo para los participantes. Sin embargo, los resultados de la investigación permitirán aumentar el conocimiento en este campo y contribuirán al desarrollo de estrategias de intervención adecuadas.

COMPENSACIÓN: No se proporcionará compensación económica por participar en el estudio.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: Toda la información recopilada será tratada de forma confidencial y anónima. Sus respuestas no contendrán su nombre ni ningún otro dato que pueda identificarlo. Su nombre no será utilizado en ningún informe publicado sobre los resultados de la investigación.

CONSENTIMIENTO / PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA: Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Usted tiene la libertad de decidir si desea o no participar. Si decide participar, puede retirarse en cualquier momento sin necesidad de dar explicaciones y sin que esto afecte su atención médica.

Nombre completo del participante: _____

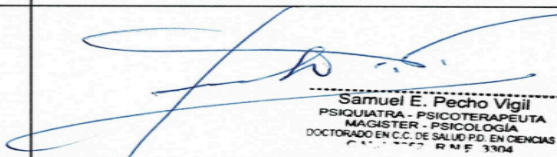
Firma del participante: _____

Fecha: _____

ANEXO 4 : VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

VALIDACIÓN DE FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO

Nombres y Apellidos	Samuel E. Pecho Vigil
Fecha de la validación (día, mes y año)	02 Diciembre 2024
Firma	 Samuel E. Pecho Vigil PSQUIATRA - PSICOTERAPEUTA MAGISTER - PSICOLOGIA DOCTORADO EN C.C. DE SALUD P.D. EN CIENCIAS C.M.P. 31772 R.N.E. 3304

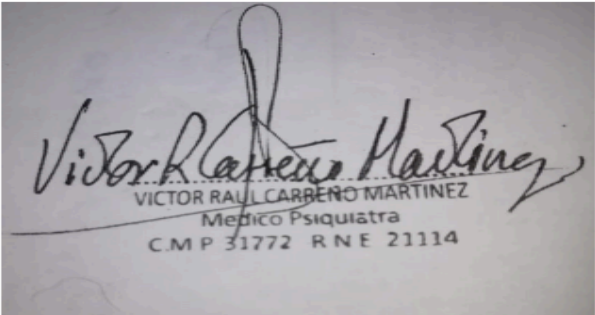
Por favor, evalúe el contenido del instrumento presentado considerando su claridad, pertinencia y utilidad para los objetivos del proyecto. Marque con una "X" la opción que considere adecuada:

	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS	X			

Apreciamos enormemente su colaboración y el tiempo dedicado a revisar este instrumento, lo cual contribuye significativamente al rigor y calidad del proyecto de investigación

VALIDACIÓN DE FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO

Nombres y Apellidos	Víctor Raúl Carreño Martínez
Fecha de la validación (día, mes y año)	03 de diciembre de 2024
Firma	 VÍCTOR RAÚL CARREÑO MARTÍNEZ Médico Psiquiatra CMP 31772 RNE 21114

Por favor, evalúe el contenido del instrumento presentado considerando su claridad, pertinencia y utilidad para los objetivos del proyecto. Marque con una "X" la opción que considere adecuada:

	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS		X		

Apreciamos enormemente su colaboración y el tiempo dedicado a revisar este instrumento, lo cual contribuye significativamente al rigor y calidad del proyecto de investigación

VALIDACIÓN DE FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO

Nombres y Apellidos	Favio Laureano Vega Galdós Médico Psiquiatra CMP 35940 RNE 16620
Fecha de la validación (día, mes y año)	11 de diciembre de 2024
Firma	

Por favor, evalúe el contenido del instrumento presentado considerando su claridad, pertinencia y utilidad para los objetivos del proyecto. Marque con una "X" la opción que considere adecuada:

	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS			Revisar y corregir concordancia con operacionalización de variables del protocolo, redacción de preguntas y sugerencias de factores asociados	

Observación: Se adjunta comentarios y sugerencias en el mismo instrumento de recolección de datos para su consideración.

Apreciamos enormemente su colaboración y el tiempo dedicado a revisar este instrumento, lo cual contribuye significativamente al rigor y calidad del proyecto de investigación

VALIDACIÓN DE FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO

Nombres y Apellidos	Kelly Lisset Sotomayor Cornejo
Fecha de la validación (día, mes y año)	03/12/2024
Firma	

Por favor, evalúe el contenido del instrumento presentado considerando su claridad, pertinencia y utilidad para los objetivos del proyecto. Marque con una "X" la opción que considere adecuada:

	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS		X		

Apreciamos enormemente su colaboración y el tiempo dedicado a revisar este instrumento, lo cual contribuye significativamente al rigor y calidad del proyecto de investigación

VALIDACIÓN DE FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO

Nombres y Apellidos	Carlos Bernardo Cano Uria
Fecha de la validación (día, mes y año)	03 de diciembre del 2024
Firma	 DR. CANO URIÁ CARLOS BERNARDO PSIQUIATRÍA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE CMP: 21544 RNE: 11580 Hosp. Nac. "Guillermo Almenara I"

Por favor, evalúe el contenido del instrumento presentado considerando su claridad, pertinencia y utilidad para los objetivos del proyecto. Marque con una "X" la opción que considere adecuada:

	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS	X			

Apreciamos enormemente su colaboración y el tiempo dedicado a revisar este instrumento, lo cual contribuye significativamente al rigor y calidad del proyecto de investigación.

ANEXO 5: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

PRUEBA PILOTO Y VALIDACIÓN DE CONSISTENCIA POR EL TEST DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH

Se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad de la ficha de recolección de datos sobre Nivel de agresividad y factores asociados con la agresividad, por ello se realizó una prueba piloto con 30 usuarios.

Estructura de la base de datos

Código	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	V28	V29	V30	V31	V32	V33	V34	V35	V36	V37	V38	V39	V40	V41		
12345	2	2	2	1	3	1	2	2	1	4	2	1	1	3	1	3	2	1	1	3	5	2	2	2	2	2	4	1	5	2	4	4	2	5	3	1	3	2	2	5	4	3	
12346	1	1	1	3	3	1	2	3	1	1	2	1	2	3	4	3	1	5	3	3	4	4	4	3	4	3	2	3	4	5	5	4	5	2	2	3	4	4	4	4	3		
12347	1	2	2	2	3	1	1	2	1	4	2	2	2	1	5	3	2	2	2	5	5	2	5	3	1	2	2	3	1	5	1	1	3	2	1	2	2	3	3	2	2		
12348	1	2	3	1	3	1	4	2	1	1	2	2	2	2	5	3	2	4	4	2	2	5	4	4	4	2	2	2	5	4	3	2	3	1	4	5	2	2	3	2	2		
12349	2	1	1	1	3	3	1	2	1	4	2	1	4	4	2	1	1	5	1	5	4	2	2	1	4	2	2	2	2	1	5	5	2	2	2	4	3	5	5	2	2		
12350	1	2	2	3	3	1	1	3	2	4	2	1	2	2	5	3	2	5	5	5	3	2	3	3	1	3	2	3	3	3	3	3	3	2	5	4	1	3	3	1	2		
12351	2	1	1	2	3	2	2	2	1	3	4	1	1	2	4	1	1	1	2	2	4	2	1	1	3	1	2	2	3	5	2	5	3	2	1	4	5	1	2	1	2		
12352	2	2	4	2	3	2	1	2	1	1	4	1	2	3	3	3	2	5	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	2	2	4	3	3	3	1	2		
12353	2	2	3	1	3	1	1	2	1	1	1	1	1	2	4	4	5	2	3	5	2	5	3	4	5	2	1	2	1	3	5	1	1	2	4	1	1	3	2	2			
12354	1	2	1	2	3	1	1	2	1	1	2	1	2	1	5	1	2	5	2	1	5	1	5	1	3	1	2	1	1	3	3	3	3	2	2	4	1	1	3	4	1		
12355	2	1	1	2	3	1	4	2	1	1	2	1	1	1	5	3	2	5	5	1	1	1	5	2	1	2	2	3	2	3	3	2	3	3	4	5	3	5	2	3			
12356	1	1	1	1	3	2	4	3	2	4	2	1	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	3	3	1	2	2	2	3	3	3	3	2	4	4	2	3	3	2	2		
12357	1	2	2	4	3	3	4	2	1	4	3	1	2	2	5	3	2	2	2	4	3	4	2	1	4	1	1	1	2	2	3	5	3	2	3	4	2	3	3	3	2		
12358	1	2	4	2	1	2	2	2	2	3	4	1	2	4	1	3	2	5	2	2	3	2	2	2	3	5	3	4	1	2	3	3	3	3	2	1	2	5	2	3	4	2	
12359	1	1	4	2	3	1	1	3	2	1	2	1	2	3	1	3	2	2	1	2	3	1	1	4	3	4	2	1	3	3	5	3	2	2	2	3	5	3	4	2			
12360	2	2	3	2	3	3	1	2	1	1	2	1	1	3	2	1	3	2	1	2	4	2	4	2	1	1	2	5	4	2	1	5	1	2	4	2	3	5	3	2	3		
12361	1	2	1	3	3	1	1	3	2	2	4	2	2	3	4	3	2	5	4	2	3	2	4	3	3	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	2	2	3	5	4	2		
12362	2	2	1	2	3	1	1	2	1	4	1	2	2	1	3	3	4	5	3	5	2	1	1	3	3	1	4	5	1	5	3	1	3	2	2	2	1	3	3	2	2		
12363	2	1	1	1	3	3	4	1	1	4	2	2	2	2	3	5	3	4	5	5	3	5	5	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	2	5	4	3	3	5	2			
12364	1	2	4	2	3	1	1	2	1	1	2	2	2	5	5	3	2	1	2	3	3	5	3	1	3	1	2	2	3	3	5	2	3	2	2	4	2	3	3	2	1		
12365	1	2	4	1	2	1	4	2	1	1	2	1	2	1	3	5	2	3	4	5	2	2	5	5	2	3	3	3	2	3	3	5	3	2	1	4	2	3	3	2			
12366	1	2	3	1	1	3	4	1	3	4	3	1	2	1	3	3	2	5	1	5	1	5	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	5	2	1	1	3	2	2		
12367	2	1	1	2	3	1	1	2	1	4	2	2	2	5	5	3	1	5	3	2	4	5	5	5	3	5	3	5	4	1	5	5	5	2	5	3	5	5	5	2	2		
12368	1	1	1	2	3	1	1	1	1	1	2	1	2	3	2	3	2	2	2	2	3	5	3	2	3	3	3	2	3	3	4	5	2	4	4	5	4	3	4	2			
12369	1	2	1	1	1	3	4	2	3	4	1	2	1	2	2	3	2	5	2	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	5	3	3	3	2	4	2	5	3	3	2		
12370	1	1	1	2	3	2	2	3	2	4	2	1	2	5	2	3	2	5	4	4	4	2	4	5	3	3	3	2	4	4	4	3	4	2	4	1	3	2	3	4	2		
12371	1	2	1	1	3	2	1	1	1	1	1	1	2	1	2	3	2	1	1	5	3	1	3	3	3	3	3	1	3	3	5	3	3	2	2	4	3	3	3	3	2		
12372	1	2	2	4	1	3	3	1	3	4	1	2	3	1	3	2	3	1	5	3	3	3	3	3	3	4	5	5	3	3	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2		
12373	1	2	2	1	3	3	4	1	1	4	2	2	2	2	1	1	2	5	1	1	3	1	3	1	3	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	4	1	1	3	1	2
12374	2	2	3	1	3	1	4	2	1	1	1	1	1	2	3	3	2	2	3	1	2	3	3	4	2	3	3	2	5	3	3	3	1	3	2	4	4	1	1	3	4	1	

Alfa de Cronbach

Test scale = mean(standardized items)						
Item	Obs	Sign	item-test correlation	item-rest correlation	average interitem correlation	alpha
genero_num	30	+	0.1580	0.0810	0.0784	0.7728
grado_inst~m	30	-	0.5846	0.5298	0.0713	0.7544
ocupacion~m	30	-	0.2336	0.1583	0.0771	0.7697
capacidad~m	30	+	0.0806	0.0028	0.0796	0.7758
triaje_num	30	+	0.4779	0.4145	0.0731	0.7593
p_c_nervio~m	30	-	0.4070	0.3390	0.0743	0.7624
p_c_explic~m	30	-	0.2448	0.1697	0.0769	0.7692
p_c_amabil~m	30	+	0.4275	0.3608	0.0739	0.7615
p_c_conten~m	30	-	0.3677	0.2976	0.0749	0.7641
p_c_emerge~m	30	-	0.2778	0.2039	0.0764	0.7679
p_c_cita_num	30	+	0.2106	0.1346	0.0775	0.7706
p_c_histor~m	30	-	0.1963	0.1200	0.0777	0.7712
impulso_go~m	30	+	0.1575	0.0804	0.0784	0.7728
discuto_am~m	30	+	0.4278	0.3611	0.0739	0.7615
enojo_num	30	+	0.3694	0.2994	0.0749	0.7640
envidioso~m	30	+	0.1500	0.0728	0.0785	0.7731
golpear_num	30	-	0.2830	0.2092	0.0763	0.7677
desacu~o_num	30	+	0.1973	0.1210	0.0777	0.7712
frustrado~m	30	+	0.4686	0.4045	0.0732	0.7597
vida_injus~m	30	-	0.3144	0.2419	0.0758	0.7663
responde_g~m	30	+	0.1622	0.0853	0.0783	0.7726
molesta_di~m	30	+	0.2720	0.1978	0.0765	0.7681
enojado_es~m	30	+	0.2634	0.1889	0.0766	0.7685
otros_opor~m	30	+	0.2509	0.1760	0.0768	0.7690
involucro~m	30	+	0.1733	0.0965	0.0781	0.7722
desacu~r_num	30	+	0.3236	0.2515	0.0756	0.7660
apacible_num	30	-	0.2952	0.2219	0.0761	0.7671
resentido~m	30	-	0.2351	0.1598	0.0771	0.7696
violencia~m	30	+	0.1699	0.0931	0.0782	0.7723
discuto_mu~m	30	-	0.1737	0.0970	0.0781	0.7721
impulsiva~m	30	+	0.4721	0.4083	0.0732	0.7595
critican_e~m	30	+	0.4406	0.3748	0.0737	0.7609
provoca_pe~m	30	+	0.5318	0.4725	0.0722	0.7568
pierdo_con~m	30	+	0.1546	0.0775	0.0784	0.7729

desconfio_~m	30	+	0.3016	0.2285	0.0760	0.7669
ninguna_ra~m	30	+	0.2186	0.1429	0.0774	0.7703
dificultad~m	30	+	0.4730	0.4092	0.0732	0.7595
gente_rie_~m	30	+	0.5359	0.4769	0.0721	0.7567
amenazado_~m	30	+	0.6795	0.6342	0.0698	0.7500
amigable_q~m	30	+	0.4845	0.4216	0.0730	0.7590
furioso_ro~m	30	+	0.2112	0.1352	0.0775	0.7706
Test scale					0.0758	0.7708

Interitem correlations (reverse applied) (obs=30 in all pairs)

$$\alpha = \frac{K - I}{K} \left(\frac{q_j^X}{\sum_{K}^{I=J} q_j^{K^I}} \right)$$

$$\alpha=0.778$$

Mediante la aplicación del Alfa de Cronbach en STATA 14.2 se obtuvo un coeficiente de 0.7708 lo que indica un nivel de confiabilidad aceptable.

ANEXO 6: APROBACIÓN POR EL COMITÉ DE ÉTICA DE LA UNMSM



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE MEDICINA
INSTITUTO DE ÉTICA EN SALUD
COMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN



"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y la
Conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"



ACTA DE EVALUACIÓN ÉTICA DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN

CÓDIGO DE ESTUDIO N°: 0270-2024

En Lima, a los nueve días del mes de octubre, en Sesión del COMITÉ DE ÉTICA EN INVESTIGACIÓN, previa evaluación del Proyecto de Tesis de Pregrado titulado: **"Nivel y factores asociados con la agresividad de los usuarios externos que acuden al Centro de Salud San Miguel "Manuel Bertonini Jordan" 2024"** presentada por **Miriam Valencia Rivera** con código 18010357, de la escuela profesional de medicina humana para optar el Título Profesional de Médico Cirujano en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

ACUERDA:

Dar por **APROBADO** dicho Proyecto, considerando que se ha cumplido satisfactoriamente con las recomendaciones en aspectos Científicos Técnicos y Éticos para la investigación en seres humanos.

"El presente documento tiene vigencia a partir de la fecha y expira el 08 de octubre de 2025"

Lima, 09 de octubre de 2024



JUAN CARLOS OCAMPO ZEGARRA
PRESIDENTE DEL C.E.I. / F.M. / U.N.M.S.M.
FACULTAD DE MEDICINA SAN FERNANDO
CODIGO DOCENTE: 043079
CMP: 043040 - RNE: 028980 - RNSE: S00415

Dr. Juan Carlos Ocampo Zegarra
Presidente del CEI/FM/UNMSM